

УДК:616.65-006.6-08

М.С.Косанов, Н.С.Нурғалиев, Б.Т.Онгарбаев, Б.Ж.Кенжебаев, З.Б.Гасанов
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Опыт лечения рака предстательной железы в Казахском НИИ онкологии и радиологии

Аннотация. В статье отмечается тенденция к росту заболеваемости, высокие показатели смертности от РПЖ, которая обусловлена поздней диагностикой. Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении болезни в ее начальной стадии.

Внедрение скрининга значительно улучшает раннюю диагностику рака простаты на ранних стадиях, что дает возможность применить к этим больным радикальные методы лечения и тем самым увеличить продолжительность жизни. Радикальная простатэктомия надежно подавляет активность простатоспецифического антигена.

Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из ведущих причин смерти мужчин пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. В структуре заболеваемости среди всех ЗН в мире РПЖ занимает 2-ое ранговое место (13,6%). По прогнозам ВОЗ к 2030 году заболеваемость и смертность от РПЖ во всем мире возрастет в 2 раза. В последние годы имеется тенденция к увеличению заболеваемости РПЖ и в Республике Казахстан. Если в 2001 году с впервые в жизни установленным диагнозом РПЖ взято на учет 534 мужчин (3,6 на 100 000 населения), то в 2011 году – 835 (4,8 на 100 000 населения); сохраняется высокая смертность среди больных раком простаты, которая в динамике нарастает: в 2001 году – 296 человека (2,0 на 100 000 населения), в 2011 году – 407 (2,4 на 100 000 населения). У больных РПЖ – один из самых низких показателей 5-летней выживаемости среди всех онкологических нозологий. Всего 32,5% больных переживают 5-летний рубеж. При анализе заболеваемости РПЖ в РК выясняется, что отмечается высокая запущенность при впервые установленном диагнозе на протяжении последних 10 лет – в 2001 году 76,1% больных РПЖ имели III-IV стадию при постановке диагноза, 2010 году – 63,3% больных. Таким образом, в РК отмечается тенденция к росту заболеваемости, высокие показатели смертности от РПЖ, которая обусловлена поздней диагностикой РПЖ и большим числом наблюдаемых пациентов с местно распространенными и диссеминированными формами РПЖ. Из этого становится совершенно очевидным факт, что заболеваемость РПЖ в нашей стране намного выше за счет не выявленного локализованного рака.

Надежды сократить число смертей от рака простаты основаны на двух тактиках: ранней диагностике и эффективном лечении

болезни в ее начальной стадии.

Наиболее эффективным методом лечения рака предстательной железы в ранних формах является оперативный. Радикальная простатэктомия при РПЖ в КазНИИОиР впервые стала выполняться с 2008 года. В дальнейшем количество оперативных вмешательств увеличивалось за счет повышения технического уровня специалистов, а так же в результате внедрения на территории РК скрининга рака простаты, благодаря чему значительно увеличилось число больных с впервые выявленными ранними формами рака предстательной железы.

Пилотный проект скрининга рака простаты был запущен в ВКО в 2012 году, что не замедлило отразиться на количестве впервые выявленных больных локализованным раком предстательной железы. Так если в 2008 году в КазНИИОиР проведено оперативное лечение 2 больным раком простаты; в 2009г – 11 б-х; в 2010г – 10 б-х; в 2011г – 6 б-х; 2012г – 14; 2013г – 33 пациента из которых 16 (50%) больных жители ВКО. Данные цифры показывают эффективность диагностики ранних форм рака простаты при скрининге.

За время наблюдения хирургическое лечение получили 74 человека. Все пациенты, получавшие хирургическое лечение в объеме радикальной простатэктомии были разделены на 3 группы по возрасту: до 60 лет, от 60 до 69 лет, от 70 до 79 лет. У всех больных до операции морфологически установлена аденокарцинома Стадия 1 – 2. Всем больным перед операцией проводилось МРТ и-или КТ органов малого таза, при которых распространенность процесса за пределы предстательной железы не определялась. В соответствии со стандартами ЕАУ 2007г. радикальному оперативному лечению подлежат больные ранними локализованными формами рака предстательной железы (1-2 стадии), ПСА не более 20нг/мл, число Глиссона не выше «7».

Как видно из таблицы у 15(20%) пациентов в послеоперационном материале выявлена инвазия опухоли в капсулу предстательной железы и-или семенные пузырьки. 5 больных (25%) из первой группы, 10 (23%) – из второй, у пациентов старше 70 лет распространенности рака за пределы капсулы простаты не определялось. У одного из этих пациентов морфологически выявлены метастазы

Возраст, лет	Кол-во б-х	п/о гистология выход за пределы капсулы (кол-во. %)		Увеличение уровня ПСА через 3 мес п/о выше 4 нг/мл	Увеличение уровня ПСА через 6 мес п/о выше 4 нг/мл	Отдал-ные метастазы
		Кол-во	%			
До 59	20	5	25	-	1	-
60-69	44	10	23	-	4	-
70-79	10	0	0	-	-	-
Всего	74	15	20		5	

в регионарные л/узлы. При дальнейшем наблюдении активность опухолевого процесса определялась по уровню ПСА в крови, УЗИ, рентгенологически и скинтиграфия костей скелета. Из больных у которых в п/о периоде выявлена распространенность опухоли за пределы капсулы простаты у 5 пациентов в раннем п/о периоде (6 мес) отмечалось повышение уровня ПСА больше 6 нг/мл (1 больной из первой группы, 4 – из второй) т.е. у 33% от количества больных с распространенной формой рака простаты, выявленной по результату п/о гистологии или 6,75% от общего числа пролеченных больных.

Таким образом, количество больных с выявленным после операции распространенным раком простаты в первой и второй возрастных группах было одинаковым. У пациентов старше 70 лет распространенности рака за пределы капсулы простаты не определялось, что может быть связано с более низким гормональным статусом этой группы больных.

Внедрение скрининга значительно улучшает раннюю диагностику рака простаты на ранних стадиях, что дает возможность применить к этим больным радикальные методы лечения и тем самым увеличить продолжительность жизни.

Радикальная простатэктомия надежно подавляет активность простатоспецифического антигена.

Тұжырым

М.С. Қосанов, Н.С. Нурғалиев, Б.Т. Онғарбаев, Б.Ж. Кенжебаев, З.Б. Гасанов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми – зерттеу институтындағы қуық асты безі қатерлі ісігі емі

Мақалада қуық асты безі қатерлі ісігі ауруының кеш диагностиканың салдарынан, аурудың өсуін және өлім көрсеткіштерінің жоғарылығын көрсетеді. Қуық асты

қатерлі ісігі бар науқастардың өлімін азайтуында 2 жолға негізделген: ерте диагностика және аурудың басты сатысында эффективті ем жүргізу.

Скрининг бағдарламасының енгізілуі қуық асты безі қатерлі ісігін ерте диагностикасын жасауға мүмкіндік береді, яғни бұл бағдарлама, сол науқастарға радикалды ем әдістерін қолдану және өмір сүруін ұзартуға мүмкіндік береді. Радикалды простатэктомия простатоспецификалық антигендердің белсенділігін тежейді.

Түйінді сөздер: қуық асты безінің қатерлі ісігі, сырқаулық, өлім, скрининг, диагностика.

SUMMARY

M.S.Kosanov, N.S.Nurgaliev, B.T.Ongarbaev, B.Zh. Kenzhebaev, Z.B.Gasanov

Experience in treating prostate cancer in the Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

In the article there is a tendency to increase the incidence and high mortality rates from prostate cancer, which is due to late diagnosis. Hopes to reduce the number of deaths from prostate cancer based on two tactics: early diagnosis and effective treatment of the disease in its initial stages.

Introduction of screening improves early diagnosis of prostate cancer in the early stages, which will allow to apply to these patients radical treatments and thereby increase life expectancy. Radical prostatectomy reliably suppresses activity of prostate-specific antigen.

Keywords; prostate cancer incidence, mortality, screening, diagnosis.